

姓 名			
性 别	男		
年 龄	37岁		
联系电话			
体检编号			
体检日期	2022-12-14		
单位部门			
体检单位			

健康体检报告

Health Examination Report



一次体检 · 终身受益

尊敬的

贵宾：

您好！

首先感谢您的信赖！

我们很荣幸为您完成了这次健康体检和健康管理服务。现将您的健康体检报告呈上
请您着重关注本次健康体检的异常部分，仔细阅读专家对您的重点问题的提示内容。

【健康风险评估与主要阳性发现】

1. 一般检查：体重指数肥胖(29.19↑)、收缩压偏高(159↑)、舒张压偏高(108↑)

耳鼻喉检查：慢性咽炎

尿常规：尿隐血弱阳性、尿蛋白阳性+

血常规五分类：平均血小板体积偏低(7.3↓)

肾功能四项：肌酐偏高(98↑)

常规十二导心电图：1、窦性心动过缓。2、T波改变。

男性下腹部彩超（输尿管膀胱前列腺）：前列腺钙化灶。

上腹部彩超（肝胆胰脾双肾）：轻度脂肪肝。肝右叶囊肿。

【健康指导建议】

1、血压偏高：您本次检查血压升高，考虑您既往血压不稳定，但未进一步诊断及治疗，长期高血压不加以控制，可引起心、脑、肾靶器官的损害，进而影响生活质量，甚至威胁生命。建议您及时到心血管内科就诊，遵医嘱按时服用降压药物，定期监测血压。注意事项：（1）限制盐量：每日应小于5克（2小勺），少食盐腌品。（2）少制食高脂食物：肥肉、动物内脏、油炸食品等。（3）多用鲜菜，每餐不宜过饱（八分饱）。（4）戒烟，限酒，少饮浓茶。（5）心理平衡，防止精神紧张，生活规律，坚持适量运动，保证充足睡眠。

2、尿蛋白阳性+：（1）该项检查可受多种因素的干扰，需多次测定才有可靠价值；（2）建议进一步检测尿微量白蛋白，如有异常改变，提示肾脏受损，请及时到肾内科进一步诊治。

3、肌酐偏高：肌酐是肌酸的代谢产物，98%的肌酸存在于肌肉，为肌肉收缩时的能量来源，释放能量后变为肌酐，由肾脏排泄。肌酐增高见于各种原因导致的肾脏损害、肾功能不全及心功能不全等。建议您1周内复查肾功能，若持续异常请立即到肾内科进一步检查，明确诊断。

4、窦性心动过缓：原因有功能性和器质性，前者见于正常人、体力劳动者、运动员或迷走神经张力过高等；有一部分人与心脏窦房结病变、颅内高压、甲状腺功能减退等器质性疾病有关。建议：定期复查；若心率<50次/分，心血管内科诊治。

5、心电图示T波改变：生理性改变常见于精神紧张、劳累、熬夜、过度吸烟等；病理性改变常见于高血压、冠心病、贫血或药物影响等。建议：复查心电图。如仍异常，请到心血管内科就诊。

6、轻度脂肪肝：脂肪肝是由于体内过多的脂肪沉积在肝脏所致，常因喜食荤食、过量饮酒及肥胖或糖尿病等引起，与高血脂、肥胖、糖尿病密切相关。合理膳食以低糖、低脂、低盐、高蛋白质、高维生素为原则，少吃油炸煎烤类食物。请定期复查血脂、肝功能、肝胆彩超。

7、肝右叶囊肿：肝囊肿是常见的肝脏良性病灶，其内为良性水囊结构，可单个或数个发生。多为先天性，通常没有症状，也不影响肝功能。有时会随年龄增长而增大，较大者直径超过5cm需要进一步诊治，请您定期复查肝脏B超。

8、前列腺钙化灶：可能与高脂饮食、饮酒、吸烟及久坐少运动或前列腺炎等因素有关。建议您多饮水、忌烟酒，忌辛辣刺激性食物，不忍尿、憋尿，定期复查。如出现尿痛、尿急、排尿不畅等症状，请及时到我院泌尿外科诊治。

9、肥胖：身体质量指数（BMI）是国际上测量与诊断超重和肥胖使用最广泛的指标， $BMI(kg/m^2) = \text{体重} / \text{身高}^2$ ，BMI 24~27.9kg/m²为超重， $\geq 28 kg/m^2$ 为肥胖。成年男性腰围 $\geq 90cm$ 、女性腰围 $\geq 85cm$ 即可诊断为中心型肥胖。超重与肥胖可增加高血压、糖尿病、血脂异常、冠心病、心肌梗死、卒中及部分肿瘤等多种慢性病的风险。建议日常膳食为低能量、低脂肪、适量蛋白质，多食全谷物、蔬菜、水果、大豆、奶类、鱼肉、坚果，避免进食油炸食物，尽量采用蒸、煮、炖的烹调方法。选择适宜的运动方式，坚持规律、适量有氧运动。每天运动不少于30分钟，每周运动5~7天。抗阻训练 2~3次/周。

10、慢性咽炎：常发生于上呼吸道炎治疗不彻底或长时间受刺激性食物或气体刺激的结果，建议平时多饮水。若长期声音嘶哑、疼痛，应去医院耳鼻喉科进行治疗。

11、温馨提示：本次建议未提及之弱阳性、偏高（↑）或偏低（↓）指标等，临床意义较小，仅供参考，无需特殊处理。

本体检报告所选择的检查项目并未涵盖所有脏器，因此医师所作出的健康诊断和健康指导建议是依据您的陈述和本次体检的结果而得出的，我们建议您对异常的结果进行随访复和其他相关检查。同时，为了您的健康，建议您至少每年进行一次健康体检。

主检医师

总检医师

一般检查

项目名称	检查结果	参考值	单位
身高	167.5		cm
体重	81.9		kg
体重指数	29.19 ↑	18.5-23.99	kg/m ²
收缩压	159 ↑	90-139	mmHg
舒张压	108 ↑	60-89	mmHg
脉搏	65	60-100	次/分

小 结： *一般检查： 体重指数肥胖(29.19 ↑);收缩压偏高(159 ↑);舒张压偏高(108 ↑);

检查医师

体检日期： 2022-12-14

内科

项目名称	检查结果
肺部	胸廓正常，双肺呼吸音清，未闻及干湿罗音
心脏	心律规整，心音正常，各瓣膜听诊区未闻及病理杂音
腹部	腹软，无压痛及反跳痛，未触及异常包块，肝脾肋下未触及，
既往史	血压不稳定，未诊断，未治疗。
家族史	无
其他	无
建议	定期复查

小 结： *内科检查(男)： 既往史:血压不稳定，未诊断，未治疗。；

检查医师：

体检日期： 2022-12-14

耳鼻喉

项目名称	检查结果
耳廓及耳周	未见异常
外耳道	未见异常
鼓膜	未见异常
听力	未见异常
鼻窦	未见异常
鼻腔	未见异常
咽部	慢性咽炎
喉部	未见异常
其他	未见异常
建议	定期复查

小 结： *耳鼻喉检查： 咽部:慢性咽炎；

检查医师：

体检日期： 2022-12-14

心电图(体检)

项目名称	检查结果
------	------

常规十二导心电图所见	采样时间:19seconds; 心率:59bpm; P波时限:116ms; QRS波时限:92ms; T波时限:214ms; PR间期:174ms; QT间期:406ms; QTc间期:402ms; P轴:13.7; QRS轴:20.0; T轴:6.1; RV5:2.01mV; SV1:1.
常规十二导心电图诊断	1、窦性心动过缓。2、T波改变。
小 结: *常规十二导心电图: 1、窦性心动过缓。2、T波改变。; 检查医师: 体检日期: 2022-12-14	

*尿常规

项目名称	检查结果	参考值	单位
*尿颜色	淡黄色	淡黄色	
*清晰度	清亮	清	
*尿胆原	阴性	阴性	
*尿胆红素	阴性	阴性	
*尿酮体	阴性	阴性	
*尿隐血	弱阳性	阴性	
*尿蛋白	阳性+	阴性	
*亚硝酸盐	阴性	阴性	
*白细胞(LEU)	阴性	阴性	
*尿葡萄糖	阴性	阴性	
*尿比重	1.015	1.003-1.03	
*酸碱度	6.5	4.5-8	
*维生素C	阴性	阴性	
*细菌计数	0.0	0-100	/uI
*鳞状上皮细胞	0.0	0-28	/uI
*非鳞状上皮细胞	0.0	0-6	/uI
*结晶检查	0	0-16	/uI
*粘液丝	1	0-320	/uI
*镜检红细胞	未见	0-偶见	/HP
*镜检白细胞	未见	0-3	/HP
*镜检管型	未见	0-偶见	/LP
*镜检结晶	未见		/HP
*透明管型	0.0	0-2	/LP
*尿红细胞	0	0-17	/uI
*尿白细胞(WBC)	0	0-28	/uI
*芽殖酵母	0.0		/uI
*假菌丝酵母	0.0		/uI
*病理管型	0.0	0	/LP
审核医师:		体检日期: 2022-12-14	

***血常规五分类**

项目名称	检查结果	参考值	单位
*有核红细胞计数	0.006	0-0.02	$\times 10^9/L$
*有核红细胞比率	0.08	0-0.4	%
*白细胞(WBC)	7.63	4-10	$\times 10^9/L$
*中性粒细胞计数	4.82	2-7	$\times 10^9/L$
*中性粒细胞百分比	63.2	50.0-70.0	%
*淋巴细胞计数	1.96	1.32-3.57	$\times 10^9/L$
*淋巴细胞百分比	25.6	20.0-40.0	%
*单核细胞计数	0.62	0.2-1	$\times 10^9/L$
*单核细胞百分比	8.1	3-10	%
*嗜酸性粒细胞计数	0.17	0.05-0.3	$\times 10^9/L$
*嗜酸性粒细胞百分比	2.2	1-6	%
*嗜碱性粒细胞计数	0.07	0.01-0.08	$\times 10^9/L$
*嗜碱性粒细胞百分比	0.9	0.2-1.2	%
*红细胞	5.26	4-5.5	$\times 10^{12}/L$
*血红蛋白	155	120-160	g/L
*红细胞压积	44.3	40-50	%
*红细胞平均体积	84.3	80-100	fL
*平均血红蛋白量	29.5	26-34	pg
*平均血红蛋白浓度	350	320-360	g/L
*红细胞分布宽度	13.2	11-14.5	fL
*血小板	219	100-300	$\times 10^9/L$
*血小板压积	0.16	0.16-0.4	%
*平均血小板体积	7.3 ↓	7.6-13.2	fL
*血小板分布宽度	16.7	9-18.1	%
审核医师:		体检日期: 2022-12-14	

***肝功二项**

项目名称	检查结果	参考值	单位
*谷丙转氨酶	16	2.4-42.1	U/L
*谷草转氨酶	16	5-43.6	U/L
*谷草/谷丙	1.00		
审核医师:		体检日期: 2022-12-14	

***总前列腺特异性抗原**

项目名称	检查结果	参考值	单位
*总前列腺特异性抗原(T-PSA)	0.732	≤ 4	ng/mL
审核医师:		体检日期: 2022-12-15	

***癌胚抗原**

项目名称	检查结果	参考值	单位
*癌胚抗原 (CEA)	0.78	≤5	ng/mL
审核医师:		体检日期: 2022-12-15	

***甲胎蛋白**

项目名称	检查结果	参考值	单位
*甲胎蛋白 (AFP)	2.53	≤8.78	ng/mL
审核医师:		体检日期: 2022-12-15	

***空腹葡萄糖**

项目名称	检查结果	参考值	单位
*葡萄糖	4.39	3.9-6.1	mmol/L
审核医师:		体检日期: 2022-12-14	

***肾功能四项**

项目名称	检查结果	参考值	单位
*尿素	6.09	3.1-8	mmol/L
*肌酐	98.0 ↑	57-97	umol/L
*尿酸	397	208-428	umol/L
*二氧化碳	22.2	20-29	mmol/L
*尿素/肌肝	0.06		
审核医师:		体检日期: 2022-12-14	

***EB病毒抗体IgA (鼻咽癌筛查)**

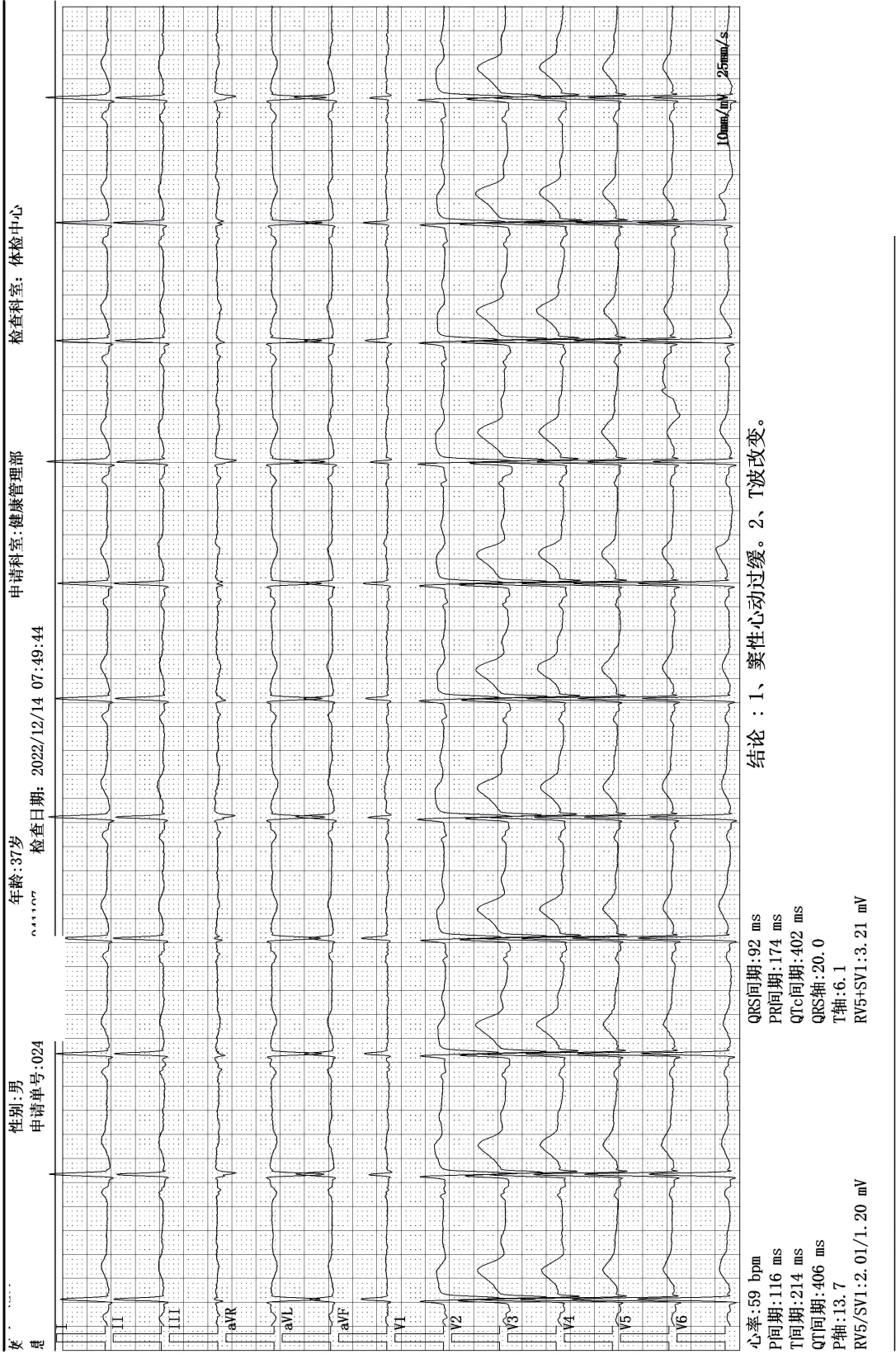
项目名称	检查结果	参考值	单位
*EB病毒壳抗原IgA抗体	阴性	阴性	COI
审核医师:		体检日期: 2022-12-14	

***血脂四项**

项目名称	检查结果	参考值	单位
*甘油三酯	0.73	≤1.7	mmol/L
*总胆固醇	4.16	0.39-5.39	mmol/L
*高密度脂蛋白	1.26	1.04-1.66	mmol/L
*低密度脂蛋白胆固醇	2.57	理想范围: <3.37mmol	mmol/L
审核医师:		体检日期: 2022-12-14	

C14呼气试验

项目名称	检查结果	参考值	单位
DPM	0	0-50	
结果	阴性		
审核医师:		体检日期: 2022-12-14	

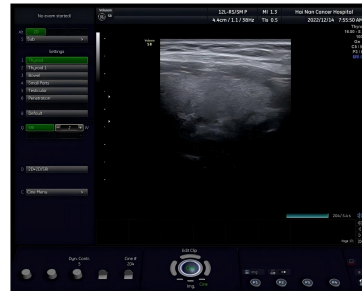
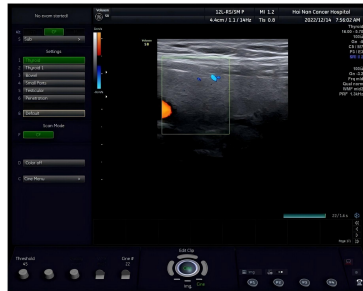


彩色超声报告单

检查日期: 2022年12月14日 08:08

姓名: 性别: 男 年龄: 37岁 门诊/体检号: 住院号: 床号:
科室: 里部 检查部位: 甲状腺及颈部淋巴结彩超 超声号: 0

告知: 超声检查受诸多因素影响, 如患者自身因素(肥胖、气体干扰、准备欠佳、配合差、病变位置特殊、疾病所处不同阶段等)、设备因素(仪器型号及性能不同、其图像质量有差异)、检查者因素(超声结论依据国内外公认的影像特征, 对图像的阅读不同检查者之间可能存在差异)等。此报告是影像检查结果, 请以病理诊断或临床最后诊断为准, 与检查相关的医疗活动应充分了解上述因素并与临床医生沟通。



超声所见:

甲状腺扫查:

甲状腺大小形态正常, 实质回声均匀, 未见明显占位性病变, CDFI: 血流信号未见明显异常。

双颈部淋巴结扫查:

未见明显肿大及异常回声淋巴结。

超声提示:

甲状腺未见明显异常。

双侧颈部未见明显异常淋巴结。

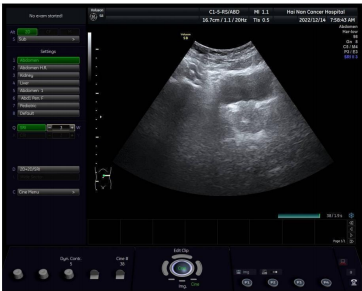
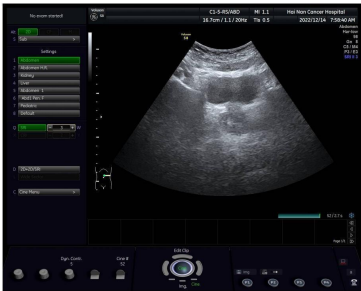
审核时间: 2022年12月14日 16:03 来源: 体检

此报告仅供临床参考! 检查医师签字有效!

检查日期： 2022年12月14日 08:08

姓名： 性别：男 年龄：37岁 门诊/体检号： 住院号： ； 床号：
科室：健康管理部 检查部位： 男性下腹部彩超（输尿管膀胱超声） 超声号：

告知:超声检查受诸多因素影响,如患者自身因素(肥胖、气体干扰、准备欠佳、配合差、病变位置特殊、疾病所处不同阶段等)、设备因素(仪器型号及性能不同、其图像质量有差异)、检查者因素(超声结论依据国内外公认的影像特征,对图像的阅读不同检查者之间可能存在差异)等。此报告是影像检查结果,请以病理诊断或临床最后诊断为准,与检查相关的医疗活动应充分了解上述因素并与临床医生沟通。



超声所见:

下腹扫查:

双侧输尿管未见扩张。
膀胱:充盈欠佳,腔内透声可。
前列腺:大小形态如常,轮廓清,前列腺回声欠均匀,其内可见强回声。

超声提示:

前列腺钙化灶。

审核时间: 2022年12月14日 19:51 来源:体检

此报告仅供临床参考! 检查医师签字有效!

X-Ray 诊断报告书

放射号: 检查日期: 2022-12-14 08:08:06
病人姓名: 性别: 男 年龄: 37 岁 病人号: 体检
申请科室: 健康管理部 门诊号: 住院号: 床号:
临床诊断: 健康查体

检查项目: 胸部正位

影像表现: 两侧胸廓左右对称, 两肺纹理清晰, 两肺内未见明显异常
密度影, 两肺门无增大, 气管居中。心影无增大, 纵隔形态可。
两侧肋膈角锐利, 两膈面光整。

诊断意见: 胸部正位片未见明显异常。

报告医师: 报告日期: 2022-12-14 20:37:36

审核医师: 审核日期: 2022-12-16 19:13:59

注: 1. 本报告书仅反映受检者当时检查情况, 仅供临床参考, 不做任何证明。
2. 本报告审核医生签名有效, 祝您健康!